生成AIで作るロールプレイ教材

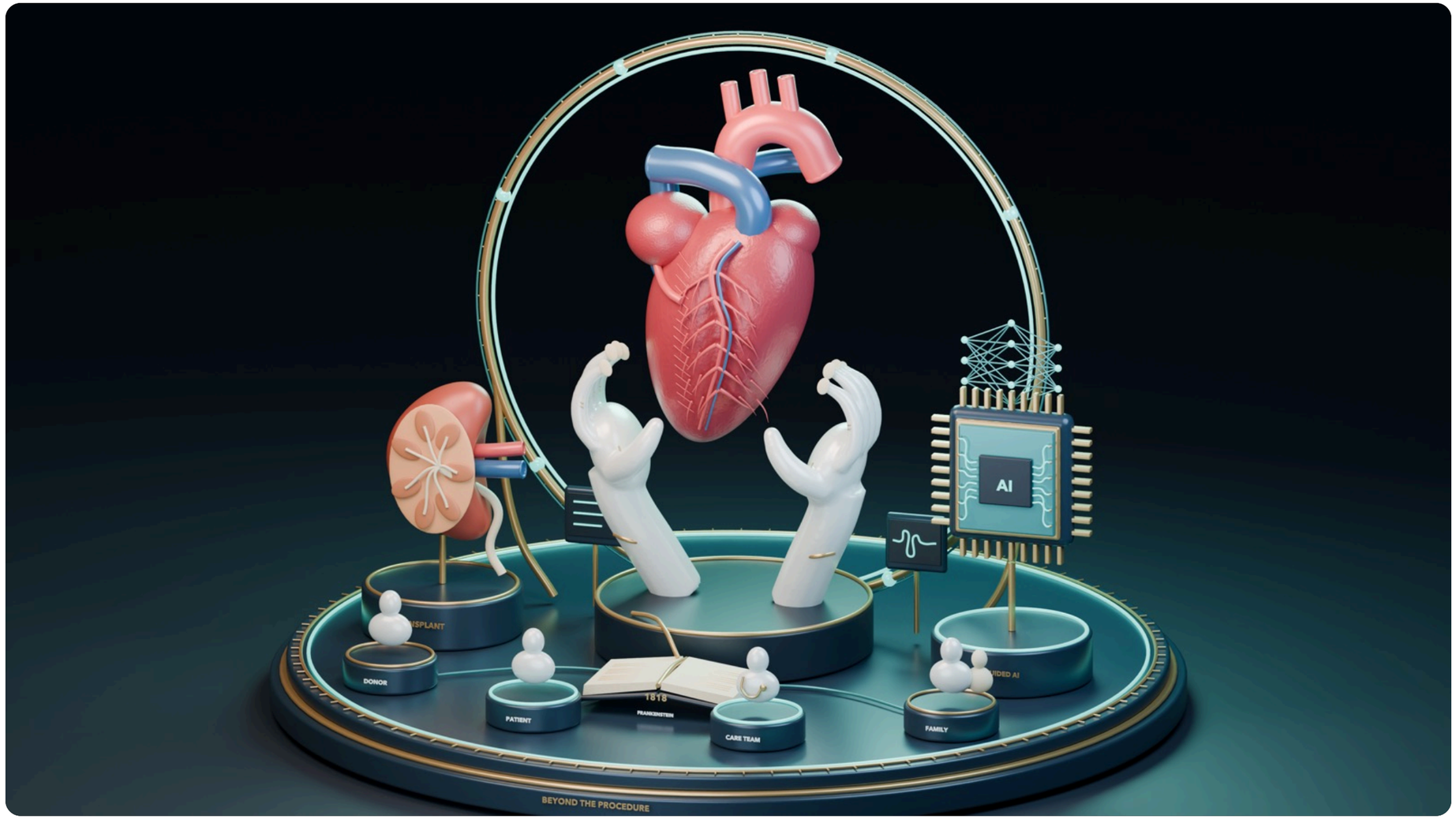
MEDC東北大 WS4　生成AI・DXで設計する明日からの各分野
医学・医療教育

香田将英

東北大学大学院医学系研究科 公衆衛生学分野

2026年10月10日　インスピレーション講演

GPT-6 Astraと作った3D作品：移植医療とAI



Gemini 3.8 Flash TTSによる禁煙外来のロールプレイ



禁煙外来の動機づけ面接シミュレーター

- 医師役として、3択の返答を**5回**選ぶ
- 患者さん(架空の50代男性)が**声で**答える
- 場面16、経路243本、結末は良好・中間・不良の3種
- 最後にMITI 4.2.1を簡略化した指標と講評が出る

スマートフォンで開けます

https://shoei05.github.io/kinen-mi-simulator/

作例でAIが担当した作業と、教員が担当した作業

AIに任せたこと

- シナリオの初稿
- 画面の実装とスマートフォン対応
- 音声と画像の生成
- 全経路の点検と採点分布の計算

教員が決めたこと

- 学習目標と狙うMillerの層
- 評価の物差し（MITI 4.2.1）
- 台詞の医学的な正確さ
- 公開の可否と倫理的な表示

制作：Claude（進行・実装・シナリオ点検）、Google Gemini（音声・画像）。教員は目的設定、妥当性の確認、修正指示を担当

学習者をどこへ連れていくかを、先に決めることが大事

結末と採点を別々に決めたため、
良好な結末なのに評価Cになる経路が93本中43本あった

- 作る形から入ると、評価の物差しが後づけになる
- 後から判定文を切り替えて対処した
- ゴール、評価、方法の順に決めれば、この食い違いは起きにくい

Magerの3つの問いと、作例での答え

どこへ向かうのか

Where am I going?

MI一致の返答(開かれた質問、聞き返し、是認)を選べるようになる

着いたことをどう知るのか

How will I know I've arrived?

5回のうち、MI不一致0回、MI一致3回以上

どうやって行くのか

How will I get there?

禁煙外来の初診で、3択を5回選ぶ分岐型の教材

Magerの行動目標の3要素:Performance(何をするか)、Conditions(どんな条件で)、Criterion(どの基準に達すれば合格か)

自分の言葉で話す練習には、Difyの禁煙外来ボット

- 医師役として、架空の喫煙者ネコタ・タマさんと自由に会話する
- 選択肢はなく、学習者の発話で話が進む
- 生成AIが患者役を演じるため、応答は毎回変わる

Difyで公開中

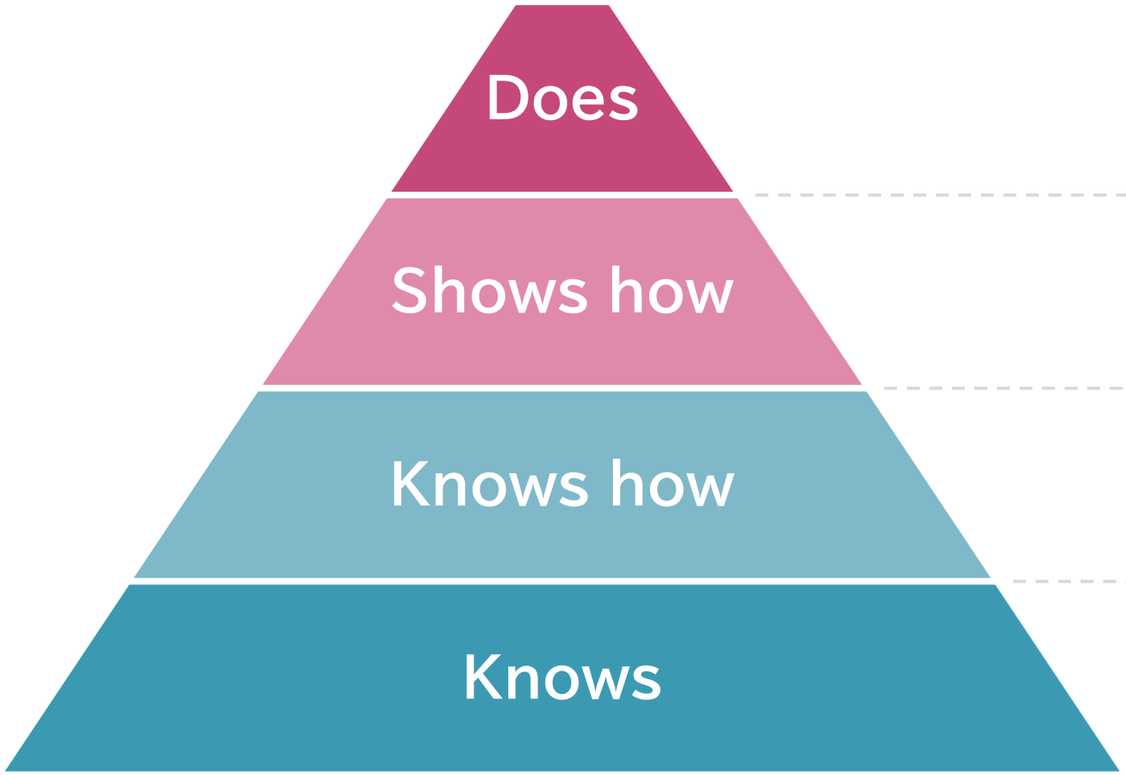
https://udify.app/chat/8lVtVAjoVxg7YvpA

分岐型、オープンワールド型、従来のロールプレイの違い

	分岐型 （シミュレーター）	オープンワールド型 （Difyボット）	従来のロールプレイ （学生同士・模擬患者）
学習者の自由度	低い。選択肢から選ぶ	高い。自分の言葉で話す	高い。自分の言葉で話す
評価の再現性	高い。同じ選択は同じ結果	低め。応答が揺れうる	相手役と評価者で変わる
想定外の応答	起きない	起きる。誤った医学情報も	起きる
費用	作成時に集中。公開後は無料	利用のたびにAIの費用	相手役と教員の時間

自由度を上げるほど学習目標との対応がゆるみ、下げるほど退屈になりやすい

Millerのピラミッドで見た各形式の位置



実際の診療・実習での観察

模擬患者・従来のロールプレイ

Difyの禁煙ボット

分岐型シミュレーター

講義・筆記試験

分岐型は返答を選ぶだけで自分では話さないため、Shows howの手前まで。自由に話すDifyボットはShows howに近い

明日から試せること：3つの問いに答えてからAIに頼む

1. どこへ向かうのか（学習者が何をできるようになるか）
2. 着いたことをどう知るのか（評価表、行動の基準）
3. どうやって行くのか（分岐型か自由会話型か）

留意点：登場人物は架空にし、実在の患者情報を入れない。台詞の医学的な正確さは教員が確かめる

作り方の手引き
（依頼文の例つき）

https://github.com/shoei05/kinen-mi-simulator/blob/main/GUIDE.md